



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
RUJUKAN PASIEN
STUNTING & WASTING**

**RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TAHUN 2026**

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 129.52/I-PND/DIR/II/2026
Tentang
Pedoman Pelayanan Gizi Terkait Stunting dan Wasting

Disusun oleh :
Penanggungjawab Bab Program Nasional



(**Chandrawati Mustikasari, S. Tr. Gz**)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(**Dr. dr. Aslichah, M.Kes AFP**)

Ditetapkan oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(**dr. Resti Lestantini, M.Kes**)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan Gizi Stunting & Wasting Rumah Sakit Prima Husada dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Pelayanan Gizi Stunting & Wasting ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan Gizi Stunting ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 24 Februari 2026

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PROGRAM GIZI TERKAIT STUNTING DAN WASTING

PENGARAH

1. dr. Fiona Paramitha, Sp.A

PELAKSANA

1. dr. Fiona Paramitha, Sp.A
2. Chandrawati Mustikasari, S. Tr. Gz
3. Nafisah Ulfa Hasanah, S. Gz
4. Sistha Ghea Aprilianti, Amd.Kep
5. Tuti Dwi Jayati, AMd. Kep
6. Apt. Pipin Purwa Ningrum, S.Farm
7. Mike Maulina Sri Hartati S. Kep, Ners
8. Nuraini Radika Rifqi, S. Kep., Ns
9. Mayputri Nabilla



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 129.52/I-PND/DIR/II/2026**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN RUJUKAN PASIEN STUNTING & WASTING

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, perlu dilakukan identifikasi kejadian stunting sejak dini
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Kerja Stunting
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Republik Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor hk.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/d/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN RUJUKAN STUNTING DAN
WASTING**

Pasal 1

- (1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan menurut umur kurang dari -2 SD, atau biasa disebut dengan balita pendek..
- (2) Wasting adalah kurangnya berat badan menurut panjang atau tinggi badan anak (BB/TB) atau biasa disebut dengan balita kurus.

Pasal 2

- (1) Rumah sakit menetapkan organisasi dalam bentuk tim yang mengurus tentang program penurunan prevalensi stunting dan wasting
- (2) Organisasi program penurunan tim stunting dan wasting dipimpin oleh staf medis atau dokter spesialis anak
- (3) Organisasi pelaksana program penurunan prevalensi stunting dan wasting terdiri dari tenaga kesehatan yang kompeten yang terdiri dari unsur:
 - a. Staf medis
 - b. Staf keperawatan
 - c. Staf instalasi farmasi
 - d. Staf instalasi gizi
 - e. Tim tumbuh kembang
 - f. Humas rumah sakit

Pasal 3

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi untuk terapi gizi terintegrasi
- (2) Asuhan gizi terintegrasi mencakup :
 - a) Deteksi dini
 - b) Rencana terapi
 - c) Pemberian terapi gizi
 - d) Monitoring dan evaluasi terapi gizi

-
- (3) Evaluasi dan monitoring terapi gizi dicatat di rekam medis pasien.

Pasal 4

- (1) Melakukan deteksi dini yang tepat terhadap tumbuh kembang anak
- (2) Deteksi dini dapat dilakukan dengan :
 - a) pengukuran antropometri yang tepat pada bayi dan balita
 - b) Penilaian perkembangan anak sesuai umur
- (3) Menilai status gizi berdasarkan Berat badan menurut Umur (BB/U), Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U)
- (4) Dilakukan pencatat dan pelaporan ke instansi terkait dan dinas kesehatan

Pasal 5

- (1) Rumah sakit menetapkan regulasi tentang sistem rujukan untuk kasus gangguan gizi yang diperlukan penanganan lanjut.
- (2) Rumah sakit membuat proses sistem rujukan untuk gangguan gizi yang perlu penanganan lanjut.
- (3) Proses pelaporan sesuai dengan rujukan

Pasal 6

- (1) Peningkatan kepaahaman kesadaran seluruh staf, pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting
- (2) Intervensi spesifik di rumah sakit
- (3) Rumah sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta penguatan jejaring rujukan
- (4) Rumah sakit menerapkan rumah sakit sayang ibu dan bayi
- (5) Rumah sakit sebagai rujukan kasus stunting dan wasting
- (6) Melakukan pemantauan dan evaluasi

Pasal 7

- (1) Rumah sakit menetapkan strategi penurunan kasus stunting di lingkungan rumah sakit
 - a) Deteksi dini kejadian stunting pada anak dan balita
 - b) Memberikan Edukasi dan pendampingan gizi pada Ibu Hamil, Remaja Putri, bayi dan balita
 - c) Pemberian makanan tambahan Ibu hamil yang

teridentifikasi KEK, remaja putri yang teridentifikasi anemia, dan bayi balita yang teridentifikasi stunting

- (2) Tujuan Strategi Penurunan Stunting
- a) Menurunkan prevalensi Stunting
 - b) Meningkatkan kualitas kehidupan sumber daya manusia
 - c) Meningkatkan pengetahuan terkait pola asuh dan asupan gizi
 - d) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

Pasal 8

Rumah sakit melakukan pendampingan intervensi dan pengelolaan gizi serta penguatan jejaring rujukan pada rumah sakit kelas dibawahnya dan FKTP

Pasal 9

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 24 Februari 2026
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR : 129.52/I-PND/DIR/II/2026
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN GIZI STUNTING &
WASTING

PEDOMAN PELAYANAN RUJUKAN PASIEN STUNTING & WASTING,

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Status gizi yang baik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan kesehatan yang pada dasarnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Anak balita, anak usia sekolah, dan ibu hamil merupakan kelompok rawan gizi yang sangat perlu mendapat perhatian khusus karena dampak negatif yang ditimbulkan apabila menderita kekurangan gizi. Stunting, merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis menjadi isu serius di Indonesia saat ini dengan angka prevalensi mencapai 19,8%. Prevalensi balita stunting dan wasting di RS. Prima Husada Malang tahun 2023 sebanyak 6 pasien, tahun 2024 sebanyak 6 pasien, dan pada tahun 2025 sebanyak 9 pasien per September.

Salah satu faktor utama penyebab tingginya angka stunting di Indonesia adalah kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan primer dan konsumsi gizi yang memadai, terutama pada keluarga dengan ekonomi rendah. Kekurangan asupan gizi pada masa kehamilan dan 1.000 hari pertama kehidupan anak dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak yang sifatnya irreversible. Selain itu, kurangnya edukasi tentang pola makan yang seimbang, pentingnya menyusui eksklusif, serta pola asuh juga berperan penting dalam memperburuk masalah stunting ini.

Dampak dari tingginya angka stunting sangatlah merugikan. Anak stunting pada akhirnya dapat menghambat potensi mereka untuk mencapai masa depan yang produktif. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki hambatan pada kemampuan belajar, pada pertumbuhan fisik dan kesehatan, yang pada akhirnya dapat menghambat potensi mereka untuk mencapai masa depan yang produktif.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta dan lembaga pemerintah lainnya. Upaya tersebut meliputi perbaikan akses terhadap makanan bergizi, peningkatan pendidikan gizi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, serta kampanye edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik untuk perkembangan anak. Selain itu, investasi dalam infrastruktur kesehatan dan sanitasi juga penting guna menjamin lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak secara optimal.

RS. Prima Husada Malang berupaya untuk menjaring balita stunting dan wasting untuk mendapatkan tatalaksana gizi lebih lanjut. Mulai sejak pasien datang di IGD, hingga pasien rawat jalan saat melakukan kontrol ke poli, serta pasien rujuk internal dan eksternal.

1.2 TUJUAN

a. Tujuan Umum

Melaksanakan penanggulangan rujukan pasien stunting dan wasting sesuai perundang-undangan

b. Tujuan Khusus

1. Membentuk Tim Penurunan Prevalensi stunting dan wasting RS Prima Husada
2. Menetapkan keseluruhan proses atau mekanisme dalam pelayanan penanggulangan, pencegahan stunting dan wasting serta laporannya.
3. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis Tim stunting dan wasting sesuai standard.
4. Melakukan rujukan pasien stunting dan wasting ke fasilitas pelayanan Kesehatan.

1.3 SASARAN

Sasaran dari kegiatan program pelayanan rujukan stunting dan wasting adalah seluruh staf medis, pasien, serta keluarga pasien RS Prima Husada Malang.

1.4 PENGERTIAN UMUM

Stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak stunting mempunyai Intelligence Quotient (IQ) lebih rendah dibandingkan rata – rata IQ anak normal (Kemenkes RI, 2018).

Wasting merupakan kurangnya berat badan menurut panjang/tinggi badan anak (BB/TB). Panjang badan digunakan untuk anak berumur kurang dari 24 bulan dan tinggi badan digunakan untuk anak berumur 24 bulan ke atas. Balita kurus (wasting) disebabkan karena kekurangan makan atau terkena penyakit infeksi yang terjadi dalam waktu yang singkat. Karakteristik masalah gizi yang ditunjukkan oleh balita kurus adalah masalah gizi akut.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelayanan Rujukan Pasien Stunting dan Wasting di Rumah Sakit Prima Husada adalah

1. Penjaringan pasien stunting dan wasting menegakkan diagnosa dan intervensi.
2. Pencatatan dan pelaporan pasien stunting dan wasting
3. Menginformasikan dan atau merujuk pasien ke puskesmas atau rumah sakit lain.

BAB III

TATA LAKSANA PELAYANAN

A. Konsep Pelayanan Secara Umum.

Penatalaksanaan pasien stunting dan wasting meliputi penemuan pasien yang datang atau dirujuk dengan melakukan skrining terlebih dahulu. Tujuan utama pengobatan pasien stunting dan wasting adalah menurunkan angka kematian dan kesakitan dengan cara menyembuhkan pasien.

1. Dilakukan secara kerjasama tim (teamwork) dokter, perawat, farmasi, Laboratorium, gizi, tim tumbuh kembang, dan tim humas
2. Pelayanan dilakukan sesuai standar.
3. Peralatan yang tersedia memenuhi ketentuan undang-undang.
4. Semua tindakan terdokumentasikan dengan baik.
5. Harus ada sistem monitor dan evaluasi.
6. Penemuan pasien stunting dan wasting dilakukan secara pasif dengan promosi aktif.
7. Penjaringan pasien terduga Stunting dan atau wasting dilakukan di unit pelayanan dengan mengukur berat badan dan tinggi / Panjang badan
8. Diagnosis stunting dan wasting ditentukan oleh dokter spesialis anak dengan pengukuran antropometri, skrining penyakit penyerta, perhitungan potensi tinggi badan anak menurut tinggi badan orang tua, dan prosedur sebagainya tergantung kondisi pasien.
9. Tidak dibenarkan mendiagnosa pasien stunting dan wasting hanya menggunakan hasil interpretasi pengukuran berat badan dan panjang/ tinggi badan karena penentuan pasien stunting dan wasting melalui berbagai macam prosedur yang dilakukan oleh dokter spesialis anak.

B. Proses Sistem Rujukan

Proses sistem rujukan stunting dimulai dari balita stunted ($Z\text{-score} > 2SD$) yang ditemukan di posyandu, kemudian setelah diberi intervensi dari puskesmas setempat belum mengalami perbaikan dan kenaikan berat badan, panjang badan, atau tinggi badan maka harus segera dirujuk pada dokter spesialis anak di rumah sakit.

Alur Proses sistem rujukan pasien stunting dan wasting adalah sebagai berikut:

1. Pasien teridentifikasi gagal tumbuh di posyandu (berat badan turun, berat badan tetap, atau berat badan naik tetapi tidak sesuai standar) dirujuk ke puskesmas setempat.
2. Pasien rujukan dari posyandu dilakukan tata laksana redflag di puskesmas setempat. Diberikan edukasi penambahan MPASI sesuai kebutuhan gizi bayi dan balita. Jika ditimbang berat badan dalam waktu 1-2 minggu tidak mengalami kenaikan maka dirujuk pada dokter spesialis anak di rumah sakit yang telah melakukan perjanjian dengan puskesmas tersebut.
3. Pasien stunted dan atau wasted rujukan dari puskesmas dilakukan serangkaian tatalaksana pasien stunting dan wasting oleh dokter spesialis anak di rumah sakit.
4. Dokter spesialis anak melakukan skrining antropometri dan skrining penyakit penyerta.

-
5. Jika tidak terdapat penyakit penyerta maka pasien mendapatkan tata laksana pasien stunting dan wasting dengan diberikan edukasi tentang penambahan energi dan zat gizi pada MPASI untuk mendukung pertumbuhan berat badan tiap harinya
 6. Jika berat badan pasien bertambah dan kondisi membaik maka pasien dirujuk kembali kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas
 7. Jika berat badan pasien tidak bertambah dan terdapat penyakit penyerta yang berat (PJB, Gagal Ginjal, Kanker) maka perlu dirujuk kepada rumah sakit Tipe A atau B untuk mendapat intervensi lebih lanjut.

C. Pencatatan dan Pelaporan Pasien stunting dan wasting

1. Pencatatan

Pencatatan pasien stunting dan wasting dilakukan setiap satu bulan sekali di unit poli anak dan instalasi rawat inap anak.

2. Pelaporan

Laporan surveilans dan jumlah bayi balita terdeteksi stunting dan wasting dilaporkan setiap bulan kepada puskesmas setempat.

BAB IV

PENUTUP

Panduan yang disusun ini merupakan langkah awal sebagai panduan Rumah Sakit untuk melakukan pengukuran, evaluasi dan tindak lanjut terhadap penanggulangan pasien stunting dan wasting. Panduan ini diharapkan dapat diterapkan oleh rumah Sakit dan menjadi pedoman Bersama dalam melakukan pelayanan rujukan pasien stunting dan wasting rumah sakit.

Hasil pelayanan rujukan pasien stunting dan wasting tersebut kedepannya diharapkan dapat diterapkan dengan sesuai alur internal rumah sakit dan eksternal. Sehingga pelaporan berjalan dengan lancar. Buku panduan ini masih dalam tahap perkembangan sehingga tidak menutup kemungkinan adanya masukan demi tercapainya perbaikan bagi buku pedoman ini.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 24 Februari 2026
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes